リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月27日（火）

第46号 朝刊

きょうの紙面 ▸ リハ評価 ▸ 参加の評価 ▸ 多職種連携 ▸ 短信 8本

■ リハ評価

脳損傷後の姿勢変化 画像解析で捉える

対象と方法、結果の限界まで読む

入院リハビリテーション中の後天性脳損傷者の姿勢を、身体にマーカーを付けず画像から評価できるか。理学療法士、作業療法士、技術者らが共同開発したシステムを、臨床家１０人、脳損傷者２０人、健常者１２人を含む観察研究で初期検証した。研究実施国は抄録に記載されていない。

操作性の評価は１００点中８５・３点。脳損傷者は全員が有害事象なく検査を完了した。頸部・体幹の側屈は三次元動作解析との一致度がともにＩＣＣ０・８３。入院中には頸部の座位側屈と体幹の立位側屈が日数に伴い減少し、臨床家が評価した姿勢異常との関連も示された。

ただし、これは少人数の観察研究であり、画像解析を使えば治療成績が上がると示したものではない。他施設や異なる撮影条件で同じ精度が出るかも未確定だ。現場では、評価者の目を不要にする道具ではなく、経過や職種間の見立てを共有する補助として捉えたい。測定できることと臨床上役立つことは分けて確かめる必要がある。



臨床家と共同開発し、測定を検証

出典 Arch Phys Med Rehabil ↗

数字で見る

20人	12人	0.83
脳損傷者	健常対照者	側屈の一致度ICC

■ 参加の評価

母指の関節症、活動を評価 過去の想起には誤差

母指ＣＭ関節症で手術を受けていない成人３３人に、活動への参加を調べるＡＣＳ３を約２週間隔で２回、ビデオ通話で実施した。現在の活動と活動保持率は良好から優れた再検査信頼性を示し、生活障害の尺度とも整合した。

以前の活動を思い出す回答は信頼性が低く、誤差が大きかった。初回の過去スコアを引き継ぐと保持率の信頼性が改善した。参加を測る意義と想起の誤差を示す。少人数・単一疾患で、他疾患への一般化や治療効果は未検証。国名は抄録にない。



出典 Am J Occup Ther ↗

■ 多職種連携

化学療法中の筋力低下 多職種で支援をつなぐ

台湾の地域病院で、化学療法中の高齢者のサルコペニア支援を見直した。看護職が多職種のケア経路を調整し、リスク確認、個別の栄養・運動支援、デジタルによる継続確認を組み合わせた。計画から評価・改善を繰り返す質改善の報告だ。

参加率１６％、１２週完遂率３３％は、８０％、７２％へ上昇した。ただし抄録に対象人数や信頼区間はなく、無作為化比較でもない。栄養や運動の単独効果とは区別する。助言だけでなく、誰が調整し、支援が切れた人をどう拾うかを考える実例となる。



出典 J Nurs Care Qual ↗

短信

〈スコーピングレビュー〉 **脳卒中デジタル支援を整理**

２１研究を支援者との関わり方や技術別に分類。効果の証明でなく、支援内容と評価の違いを示す地図として読む。

出典 J Multidiscip Healthc ↗

〈総説〉 **脳卒中ＡＩ、臨床有用性は課題**

上肢・言語・認知の総説。評価や個別化への可能性と、臨床的な有用性・他の手段への優位性の未確立を分けている。

出典 Curr Opin Neurol ↗

〈単群・概念実証〉 **低舌圧高齢者、短期訓練を検証**

低舌圧の高齢者１３人で５日間の舌挙上訓練後、最大舌圧が増加。対照のない初期検証で、嚥下障害の改善は未証明。

出典 J Oral Rehabil ↗

〈Cochrane SR〉 **透析中の音楽、効果は不確実**

２７試験・１５８４人のレビュー。短期の疲労や痛みの軽減は低確実性。血圧への効果は非常に不確かで、長期成績もない。 出典 Cochrane ↗

〈総説〉 **多発性硬化症、早期から支援**

最新総説は症状だけでなく活動・参加や社会的要因の評価を重視。早期の個別・多職種支援と、アクセス格差の検討を促す。 出典 Curr Opin Neurol ↗

〈検討会資料〉 **医療職の養成、地域で検討**

厚労省の第５回検討会資料は、地域の養成・確保体制の枠組みを提示。議論の資料であり、配置基準の変更決定ではない。 出典 厚生労働省 ↗

〈科学助言〉 **女性の循環器ケアを横断化**

米国の学会助言は、診療・教育・研究・地域連携の４本柱で専門センターを提案。効果を比較した臨床試験ではない。

出典 Circulation ↗

〈尺度開発〉 **小児リハ、医療者の知識を測る**

タンザニア北部で多職種の知識・態度・実践を測る４２項目を検証。因子分析は１０２人と２１０人の別集団で実施した。 出典 Front Rehabil Sci ↗